

Chirurgie de suspension vaginale

Information pour le patient · Réancrage du fond vaginal avec vos propres tissus — sans prothèse (mesh)

WARWIKI

La suspension vaginale corrige le prolapsus apical — chute du **fond vaginal ou de l'utérus** — en le réancrant à vos propres ligaments pelviens solides. Elle utilise votre **tissu natif**, sans prothèse (mesh), s'effectue entièrement par le vagin (pas d'incision abdominale) et offre un soutien durable.

À propos de cette intervention

Le fond vaginal est fixé par des points de suture à un ligament solide du pelvis. Les deux techniques courantes sont :

- **Suspension aux ligaments utéro-sacrés (USLS)** — ancrage aux ligaments utéro-sacrés au fond du pelvis
- **Fixation au ligament sacro-épineux (SSLF)** — ancrage au ligament sacro-épineux, vers le côté

Les deux utilisent **votre propre tissu** (points permanents), sans mesh. Elles sont souvent combinées à des réparations de la paroi antérieure ou postérieure, et réalisées en même temps qu'une hystérectomie si nécessaire.

Comparaison avec d'autres techniques

La **sacrocolpopexie** soulève le vagin avec une prothèse abdominale ; elle peut être légèrement plus durable. La suspension vaginale évite la prothèse et l'incision abdominale. Votre chirurgien vous aidera à peser les avantages et inconvénients.

COMPRENDRE LES TERMES

Apex / fond vaginal

Le sommet du vagin, qui peut descendre en cas de prolapsus.

Suspension

Réancrage du fond vaginal à un ligament solide.

USLS

Suspension aux ligaments utéro-sacrés.

SSLF

Fixation au ligament sacro-épineux.

Tissu natif

Vos propres tissus — aucune prothèse (mesh) n'est utilisée.

Prolapsus apical

Descente du fond vaginal, souvent après une hystérectomie.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? L'intervention se fait sous anesthésie ; vous ne ressentez rien pendant l'opération, et il n'y a pas d'incision abdominale. Avec la technique SSLF, certaines personnes ressentent une **gêne dans la fesse ou en haut de la cuisse** pendant quelques jours à quelques semaines, le temps de la cicatrisation — cela disparaît habituellement seul.

Comment vous préparer

- Suivez les **instructions d'anesthésie** (jeûne, arrêt des anticoagulants selon les consignes).
- Un bilan préopératoire sera réalisé ; d'autres réparations ou un geste anti-fuites peuvent être combinés.
- Ne fumez pas ; organisez un transport et une aide à domicile.

Déroulement

- 1 Vous êtes sous anesthésie ; des antibiotiques sont administrés.
- 2 Par le vagin, le fond vaginal est suturé à un ligament pelvien solide.
- 3 Les réparations de paroi prévues sont effectuées.
- 4 Une sonde et parfois un méchage vaginal sont mis en place brièvement.

Après la chirurgie

- Retour à domicile le jour même ou après une nuit ; des saignements légers ou pertes sont normaux.
- **Évitez les efforts, les poussées et les rapports sexuels pendant environ 6 semaines.**
- La gêne dans la fesse (avec SSLF) diminue en quelques semaines ; gardez les selles molles.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre, des frissons ou des saignements abondants
- Une **impossibilité d'uriner** ou une douleur pelvienne qui s'aggrave
- Une **douleur vive dans la fesse ou la jambe**, ou un nouvel engourdissement

TROIS CHOSES À RETENIR

1. La suspension vaginale soulève le fond vaginal avec vos propres ligaments — sans mesh, par voie vaginale uniquement.
2. Les techniques courantes sont l'USLS et la SSLF ; la sacrocolpopexie est l'alternative avec prothèse/voie abdominale.
3. Évitez les efforts et les rapports sexuels ~6 semaines. Une gêne fessière légère peut survenir avec la SSLF ; appelez en cas de fièvre, saignement abondant ou douleur vive.